

Business Requirement

Feature Requirement

Pendaftaran Rawat Jalan

LEVEL PRIORITAS	DESKRIPSI SINGKAT
P0	Critical , merupakan bagian dari MVP Product
P1	Must Have , eksistensinya tidak sefatal P0
P2	Should Have , secara signifikan meningkatkan kenyamanan pengguna
P3	Low , fitur tambahan atau kosmetik product
P4	Enhancement , inovasi masa depan

Legend Phase

	Phase 1
[**]	Phase 2
[***]	Phase 3
[****]	Phase 4

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
Identifikasi & Pencarian Pasien	Sebagai petugas pendaftaran, saya ingin mencari pasien dengan cepat & memastikan identitasnya benar, agar pasien tidak tertukar dengan pasien lain.	Alur: - Petugas membuka halaman pendaftaran rawat jalan dan memilih untuk mendaftarkan pasien (baru atau lama). - Sistem menyajikan pencarian pasien sebagai langkah pertama — sebelum membuat record baru, sistem selalu memastikan pasien belum pernah terdaftar. - Petugas mencari pasien menggunakan salah satu dari: Nomor Rekam Medis (No. RM), NIK, Nama pasien, Tanggal Lahir, Alamat pasien. <i>Sistem mendukung pencarian minimal berdasarkan No RM, NIK, atau Nama. Sistem dapat diperluas untuk pencarian berdasarkan kombinasi identitas lain sesuai kebutuhan rumah sakit.</i> - Sistem menampilkan daftar kandidat hasil pencarian beserta penanda identifikasi minimum (nama lengkap, tanggal lahir, alamat). Bila hasil > 1, petugas memilih kandidat yang benar. - Sebelum melanjutkan ke registrasi/kunjungan baru, petugas wajib melakukan verifikasi dua identitas: konfirmasi nama lengkap dan tanggal lahir kepada pasien secara verbal. - Bila pasien tidak ditemukan setelah pencarian, petugas mengambil jalur “registrasi pasien baru”. Aturan: - Pencarian harus mendukung pencocokan yang toleran terhadap perbedaan kapitalisasi dan spasi (mis. “siti aisyah” = “Siti Aisyah”). <i>Konteks operasional: rata-rata 200–400 pasien RJ/hari di RS C/D, dengan peak pagi 07–11 (sekitar 60–70% volume harian terkonsentrasi di rentang ini). Desain pencarian harus responsif walau database pasien sudah berisi puluhan ribu record; hasil pencarian wajib muncul ≤ 2 detik agar tidak menambah panjang antrian.</i>	P0	✓ Hasil pencarian tampil dalam ≤ 2 detik untuk database hingga 100.000 pasien. ✓ Sistem menampilkan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir) secara jelas pada hasil pencarian dan halaman registrasi. ✓ Informasi identitas pasien tersedia untuk membantu petugas melakukan verifikasi identitas pasien sebelum melanjutkan proses registrasi. ✓ Petugas dapat melihat informasi identitas pasien tanpa perlu membuka halaman detail pasien. ✓ Pencarian dengan kata kunci umum (mis. “Ahmad”) menampilkan hasil dengan paginasi yang tidak menghambat performa.
Registrasi Pasien Baru (Input NIK / Manual)	Sebagai petugas, saya ingin mendaftarkan pasien baru dengan cepat menggunakan NIK atau input manual,	Alur: - Setelah pencarian tidak menemukan pasien, petugas membuka form Registrasi Pasien Baru. - Petugas memasukkan NIK pasien (16 digit angka). Sistem otomatis memanggil validasi ke Disdukcapil. Notes plan bridging Disdukcapil	P0	✓ Pasien baru dapat didaftarkan dengan field mandatory minimum dalam ≤ 90 detik (kasus normal). ✓ Saat Disdukcapil down, registrasi tetap dapat diselesaikan; record otomatis masuk daftar tindak lanjut sinkron.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
	agar tetap melayani walau Disdukcapil bermasalah.	• <i>Bila Disdukcapil merespons sukses, data dari Disdukcapil ditampilkan sebagai isian awal form yang dapat dikoreksi petugas.</i> • <i>Bila Disdukcapil tidak merespons (timeout / down) atau NIK tidak ditemukan, sistem TIDAK memblok registrasi. Petugas melanjutkan dengan input manual;</i> • Bila pasien tidak memiliki NIK (bayi baru lahir, WNA, pasien tak dikenal), petugas melompati input NIK dan memilih jenis identitas alternatif (Paspor/KITAS) - lihat fitur Identitas Fleksibel. • Setelah data terisi, sistem menjalankan pengecekan duplikat di latar (lihat fitur Pencegahan Duplikat) sebelum No. RM diterbitkan. • Begitu disimpan, No. RM otomatis tergenerate; record pasien siap dipakai untuk pembuatan kunjungan. Aturan: • NIK adalah identitas utama (target), namun TIDAK blocking. Akses layanan tidak boleh ditolak hanya karena NIK belum tervalidasi. • Format NIK: 16 digit numerik. Bila kurang/lebih, tampilkan pesan validasi. • Field mandatory minimum: Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Jenis Identitas, Alamat. • Field mandatory minimum pada fitur Registrasi Pasien Baru merupakan data minimum yang diperlukan untuk membuat rekam medis dan menyelesaikan registrasi pasien. Kebutuhan field tambahan dapat berlaku sesuai jenis penjamin, jenis layanan, atau kebutuhan integrasi dan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Data Requirement. <i>Konteks operasional: estimasi 5–10% kunjungan harian adalah pasien baru (sekitar 20–40 pasien baru/hari). Form yang terlalu panjang langsung menambah waktu layan di jam sibuk; desain harus memungkinkan registrasi cepat dengan field minimum + pelengkapan bertahap.</i>		✓ No. RM tergenerate unik setelah pengecekan duplikat lolos. ✓ Pasien tanpa NIK tetap dapat didaftarkan dengan identitas alternatif. ✓ Field non-mandatory tidak memblok penyimpanan.
Tinjau & Update Data Pasien Lama	Sebagai petugas, saya ingin meninjau dan memperbarui data pasien lama yang	Alur:		✓ Data pasien lama tampil ter-isi otomatis dari record yang ada. ✓ Petugas dapat memperbarui field; setiap perubahan tercatat audit (nilai sebelum/sesudah).

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
	sudah tersimpan sebelum melanjutkan kunjungan, agar data pasien tetap akurat dan mutakhir.	- Setelah pasien lama ditemukan dan identitas terverifikasi, petugas membuka form data pasien yang sudah ter-is i otomatis dari record yang ada. - Petugas meninjau data. Bila ada yang berubah (mis. alamat, no. telepon, pekerjaan), petugas memperbaruinya. - Setelah data dikonfirmasi, petugas lanjut ke pemilihan penjamin & layanan. - Setiap perubahan tercatat audit: field, nilai sebelum, nilai sesudah, petugas, waktu. Aturan: - Form & daftar field sama dengan Registrasi Pasien Baru (acuan: Data Requirement); bedanya form ter-is i dari record dan tidak membuat No. RM baru serta tidak menjalankan pengecekan duplikat (pasien sudah teridentifikasi). - Update bersifat opsional — bila tidak ada perubahan, petugas dapat langsung lanjut. - Field sensitif yang berdampak pada identitas (NIK, nama lengkap, tanggal lahir) memerlukan otorisasi tambahan dari Kepala RM (lihat Data Sosial & Merge/Unmerge). Konteks Operasional: estimasi 60–80% kunjungan adalah pasien lama. Sebagian besar hanya butuh konfirmasi cepat tanpa perubahan; desain harus memungkinkan "lihat → lanjut" cepat, dengan update hanya bila perlu. Halaman wajib loading cepat (≤ 1 detik).		✓ Field sensitif (NIK/nama/tanggal lahir) memerlukan otorisasi tambahan. ✓ Tidak membuat No. RM baru dan tidak menjalankan pengecekan duplikat. ✓ Bila tidak ada perubahan, petugas dapat langsung lanjut ke penjamin/layanan.
Penanda Prioritas (Kartu Prioritas)	Sebagai petugas, saya ingin pasien pemegang Kartu Prioritas dikenali dan didahulukan, agar pasien yang berhak mendapat layanan prioritas terlayani sesuai ketentuan RS.	Alur: - Pada form pendaftaran terdapat field Kartu Prioritas (Ada/Tidak; bila Ada, isi Nomor Kartu Prioritas) — mengikuti v1. - Bila Kartu Prioritas = Ada, kunjungan ditandai prioritas: nomor antrean diberi penanda khusus, dan pasien ditandai prioritas di dashboard. - Pemanggilan poli mendahulukan pasien berpenanda prioritas (urutan lebih awal dalam kuota yang sama).		✓ Field Kartu Prioritas (Ada/Tidak + Nomor) tersedia di form pendaftaran. ✓ Pasien Kartu Prioritas = Ada mendapat penanda pada nomor antrean & dashboard.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		Sumber prioritas adalah Kartu Prioritas saja. Lansia & disabilitas tidak otomatis menjadi prioritas — bila RS ingin mendahulukan mereka, caranya melalui pemberian Kartu Prioritas.		
Pencegahan Duplikat Rekam Medis	Sebagai petugas, saya ingin diingatkan bila pasien yang akan saya daftarkan sudah pernah terdaftar, agar tidak membuat RM ganda.	Alur: - Saat petugas mengisi form registrasi pasien baru atau setelah validasi NIK Disdukcapil, sistem menjalankan skoring kemiripan di latar tanpa mengganggu pengisian. - Skoring mempertimbangkan: kecocokan NIK persis (skor tertinggi), kemudian kombinasi kemiripan nama + tanggal lahir + alamat dengan toleransi typo. - Bila skor kemiripan melewati ambang yang dikonfigurasi, sistem menyela petugas dengan dialog: menampilkan daftar kandidat pasien existing yang serupa, lengkap dengan No. RM, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan kunjungan terakhir. - Petugas memilih salah satu dari tiga aksi: (a) Gunakan pasien existing → batalkan registrasi baru, lanjut ke kunjungan dengan pasien existing; (b) Tetap buat baru — petugas wajib memberi alasan singkat (mis. “nama sama, orang berbeda, terkonfirmasi”); (c) Tinjau ulang — kembali ke form untuk mengoreksi data. - Keputusan petugas (existing/baru/koreksi) beserta daftar kandidat yang ditolak tercatat dalam jejak audit. Aturan: - Tidak ada auto-merge — sistem hanya menyarankan; keputusan akhir SELALU di tangan petugas. - Ambang skor kemiripan configurable per-RS (master setting), karena profil populasi & toleransi tiap RS bisa berbeda. - Sela hanya ditampilkan bila skor > ambang. Skor menengah/rendah cukup dicatat di latar tanpa mengganggu petugas — menghindari false-positive yang mengganggu produktivitas. - NIK persis = kandidat selalu ditampilkan (tidak peduli ambang). Konteks operasional: duplikat RM adalah salah satu pain point utama v1; bahkan dengan rata-rata 20–40 pasien baru/hari, akumulasi dalam setahun berarti potensi ratusan record ganda.	P0	✓ Skoring berjalan di latar tanpa menambah waktu pengisian form. ✓ Sela hanya muncul bila skor > ambang configurable. ✓ Petugas memiliki 3 opsi keputusan dengan jejak audit lengkap. ✓ NIK persis selalu memunculkan kandidat (tidak peduli ambang). ✓ Tidak ada auto-merge dalam kondisi apa pun. Notes : masih bisa terukur, udah cukup clear intensinya, Duplikat RM lumayan painful. Pencegahan di awal jadi lebih bagus Selalu ada causenya, kenapa petugas membuat pasien baru terus menerus. Bisa jadi karena saat search ga ketemu. Yang skrg hanya search 1 text , padahal 5 angka hanya hanya nomor terakhir - secara experience lebih mengarahkan

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		<i>Desain dialog harus to-the-point — petugas di jam sibuk tidak punya waktu mempelajari layar yang penuh.</i> <i>Pengecekan 3 kategori</i> - nama - jenis kelamin - tanggal lahir		
Identitas Fleksibel (tanpa NIK)	Sebagai petugas, saya ingin tetap dapat mendaftarkan pasien yang belum/tidak memiliki NIK (bayi, WNA, pasien tak dikenal), agar pasien tidak tertolak.	Alur: • Pada form Registrasi Pasien Baru, petugas memilih jenis identitas dari dropdown: NIK (default), Paspor, KITAS, KIA, KK, atau “Tidak Ada Identitas”. • <i>Bila memilih selain NIK, validasi Disdukcapil tidak dipanggil; petugas mengisi nomor identitas alternatif sesuai jenis yang dipilih.</i> • <i>Bila memilih “Tidak Ada Identitas” (kasus: bayi baru lahir belum diberi nama definitif, WNA tanpa dokumen, pasien tak dikenal/IGD), petugas dapat melanjutkan dengan nama sementara (mis. “By Ny. Siti”, “Mr. X”).</i> Aturan: • Sistem WAJIB dapat membuat No. RM tanpa NIK — No. RM tidak boleh bergantung pada NIK. <i>Konteks operasional: kasus pasien tanpa NIK relatif jarang per hari (mungkin 1–3 kasus, terutama IGD/persalinan), namun bila sistem tidak menangani, dampaknya fatal: pasien IGD tak dikenal harus ditolak/ditunda — melanggar standar layanan gawat darurat.</i>	P 1	✓ Pasien tanpa NIK tetap dapat didaftarkan dan memperoleh Nomor Rekam Medis. ✓ Pemilihan jenis identitas selain NIK tidak memanggil validasi Disdukcapil. ✓ Fitur yang memerlukan NIK (misalnya bridging BPJS pada Phase 2) tidak dapat digunakan sebelum identitas yang diperlukan dilengkapi.
Penjaminan Umum & Asuransi	Sebagai petugas, saya ingin menentukan penjamin pada setiap kunjungan pasien agar layanan, administrasi, dan proses klaim dapat mengikuti metode pembayaran yang berlaku pada	Alur Umum: • Setelah identitas pasien terkonfirmasi, petugas memilih jenis penjamin: Umum, Asuransi, atau BPJS. • Bila pilih Umum: tidak ada langkah tambahan; petugas lanjut memilih jenis layanan, poli/dokter, lalu mencetak nomor antrian. Alur Asuransi: • Petugas memilih nama asuransi dari master data asuransi yang dikelola RS. • Petugas memasukkan nomor polis asuransi pasien (text input).	P 0	✓ Pasien Umum dapat menyelesaikan registrasi tanpa langkah tambahan dibanding alur dasar. ✓ Pasien Asuransi mendapat dokumen jaminan tercetak sesuai template per-asuransi. ✓ Penjamin tersimpan sebagai atribut kunjungan, bukan permanen pada pasien. ✓ Tidak ada panggilan ke pihak asuransi swasta di MVP.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
	kunjungan tersebut.	- Sistem TIDAK melakukan verifikasi otomatis ke asuransi (tidak ada bridging swasta). - Setelah registrasi tersimpan, sistem menyediakan opsi cetak dokumen jaminan/berkas klaim sesuai template per-asuransi. - Template dokumen jaminan dapat dikonfigurasi per-RS (master setting). Aturan: - Jenis penjamin adalah atribut PER-KUNJUNGAN, bukan permanen pada pasien. Satu pasien dapat berganti penjamin antar-kunjungan. - Cetak dokumen jaminan bersifat opsional; tidak memblok finalisasi pendaftaran. <i>Konteks operasional: dari total pasien RJ harian, estimasi distribusi penjamin di RS C/D acuan: 70–80% BPJS, 10–20% Umum, 5–15% Asuransi. Karena jalur Umum & Asuransi adalah tulang punggung MVP (BPJS bridging baru Phase 2), kedua jalur ini wajib mulus 100% sejak rilis.</i>		
Ganti Penjamin**	Sebagai petugas, saya ingin mengubah penjamin pasien yang masih dalam proses kunjungan dengan aman, agar data administrasi tetap konsisten dan risiko klaim gagal dapat diminimalkan.	Alur: - Saat kunjungan masih berjalan (belum selesai), petugas dapat membuka detail penjaminan untuk mengubah jenis penjamin. - Petugas memilih penjamin baru. Sebelum menyimpan, sistem mengecek detail kewajiban yang masih kurang untuk tipe penjamin baru. - Sistem membandingkan kewajiban penjamin lama vs baru: dokumen yang dibutuhkan, validasi yang harus ada, langkah administratif lain. - Bila ada kewajiban penjamin baru yang BELUM terpenuhi (mis. Umum→BPJS membutuhkan data BPJS), sistem TIDAK menyimpan perubahan begitu saja. Sistem mengarahkan petugas ke langkah yang kurang - Setelah seluruh kewajiban penjamin baru terpenuhi, perubahan tersimpan. - Riwayat perubahan penjamin (dari→ke, alasan, petugas, waktu) tercatat audit. Aturan: - Ganti penjamin TIDAK BOLEH menjadi simpan-paksa tanpa pemenuhan syarat — ini dapat menyebabkan klaim gagal.	P0	✓ Ganti penjamin tersedia selama kunjungan belum selesai. ✓ Sistem mengarahkan petugas ke langkah yang kurang sebelum menyimpan. ✓ Tanpa pemenuhan syarat, perubahan tidak dapat disimpan kecuali via override Supervisor. ✓ Seluruh perubahan tercatat audit lengkap. Notes FE : Perlu dihighlight sampe casemix Behaviornya bagaimana, ending dari BPJS bagaimana. Notes BE ; - Consideration : proses integrasi, udah di akhir (ada SEP, ada rujukan) perlu dihandle - Informasi ke third party

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		- Seluruh perubahan penjamin beserta alasan, petugas, dan waktu perubahan tercatat dalam audit trail. - Nasib artefak penjamin lama (mis. SEP lama saat Umum→BPJS, atau SEP lama saat BPJS→Umum) MERUPAKAN Open Question yang harus dikoordinasikan dengan tim Billing/Casemix — <i>Konteks operasional: kasus ganti penjamin di pertengahan kunjungan tidak terlalu sering (estimasi <5% kunjungan), namun ketika terjadi seringkali menyebabkan klaim tertolak — dampak finansialnya nyata.</i>		- Perlu mengubah layanan, obat dll terkait dengan BPJS. Bisa jadi ada tindakan yang tidak ada di kelas lain atau tipe penjamin lain.
Informasi Piutang (Info-Only)	Sebagai petugas, saya ingin tahu pasien punya piutang sebagai informasi, tanpa terhalang mendaftarkan pasien tersebut.	Alur: - Setelah pasien teridentifikasi, sistem otomatis memuat status piutang pasien dari modul Billing dan menampilkannya sebagai indikator di area informasi pasien (mis. banner, badge). - Indikator menampilkan: ada/tidak piutang, jumlah piutang (bila ada), dan link “detail” yang membuka rincian (read-only). - Petugas tidak diharuskan melakukan apa pun atas indikator; tidak ada blocker yang menghentikan alur pendaftaran. Aturan: - Piutang adalah INFORMASI — tidak blocking, tidak ada dialog konfirmasi yang harus di-acknowledge. - Petugas TIDAK boleh ditugaskan untuk menagih piutang di loket pendaftaran — itu fungsi kasir/billing. - Bila pasien atau petugas ingin menyelesaikan piutang, petugas dapat mengarahkan pasien untuk ke kasir tanpa menghentikan pendaftaran. (tidak terkait dengan tampilan di sistem, pasien diarahkan ke kasir langsung oleh petugas) <i>Konteks operasional: pendaftaran adalah pintu masuk pasien ke layanan; menahan pasien karena piutang melanggar prinsip akses layanan kesehatan dan dapat memunculkan keluhan publik. Fungsi pendaftaran dipisahkan tegas dari fungsi penagihan.</i>	P 1	✓ Indikator piutang tampil sebagai informasi tanpa dialog blocker. ✓ Tidak ada langkah yang mewajibkan penyelesaian piutang sebelum pendaftaran lanjut. ✓ Detail piutang dapat dibuka read-only oleh petugas berwenang.
Skrining Batuk (TEMPO)	Sebagai petugas/RS, saya ingin mendeteksi dini pasien dengan keluhan batuk, agar mencegah penularan TB ke	Alur (loket): - Setelah identifikasi pasien selesai, sebelum lanjut memilih layanan, sistem menampilkan satu pertanyaan: “Apakah pasien batuk?” dengan dua pilihan: Ya / Tidak. - Petugas menanyakan kepada pasien dan memilih jawaban.	P 1	✓ Pertanyaan tunggal muncul untuk setiap kunjungan baru sebelum pemilihan layanan. ✓ Jawaban “Ya” men-set penanda yang tampil di seluruh unit hilir.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
	pasien & petugas lain.	- Bila YA: sistem menandai penanda “Skrining Batuk: Positif” pada kunjungan; tampilkan panduan singkat (“Berikan masker kepada pasien dan arahkan ke ruang tunggu terpisah”); tandai antrean sebagai prioritas. - Penanda diteruskan ke poli tujuan agar dokter & perawat mengetahui sebelum pasien masuk ruang periksa. Alur (APM): - Saat pasien check-in via APM, layar menampilkan pertanyaan yang sama setelah konfirmasi identitas. - Bila pasien memilih “Ya”: APM menampilkan instruksi visual untuk mengambil masker (lokasi disebut), antrean dicetak dengan penanda prioritas, dan pasien diarahkan ke area tunggu terpisah. Aturan: Skrining HANYA satu pertanyaan tunggal — tidak boleh diperluas menjadi kuesioner gejala panjang. Penilaian gejala mendalam adalah ranah unit klinis. - Penanda “Skrining Batuk: Positif” bertahan sepanjang kunjungan dan diteruskan ke RI bila pasien berlanjut. - Pasien dengan penanda positif diprioritaskan dalam antrean poli (mendapat slot lebih awal dalam kuota yang tersedia). <i>Konteks operasional: estimasi 2–5% pasien RJ harian memiliki keluhan batuk; bila pemisahan dini tidak dilakukan, satu pasien TB infeksius di ruang tunggu bersama dapat menularkan ke puluhan pasien & petugas — dampak kesehatan publik dan akreditasi sangat besar.</i> <i>Notes : Untuk fitur skrining ini configurable, bisa ada atau tidak tergantung rs</i>		✓ Antrean poli memprioritaskan pasien dengan penanda positif. ✓ APM memberikan instruksi visual jelas untuk pengambilan masker dan area tunggu terpisah.
Pilih Layanan & Poli/Dokter	Sebagai petugas, saya ingin memilih layanan & poli/dokter dari slot yang valid — baik untuk pasien yang diperiksa sekarang maupun yang dijadwalkan — agar tidak terjadi	Tiga case yang harus didukung satu komponen ini: Pendaftaran Langsung — pasien datang dan diperiksa saat itu juga. Petugas mendaftar, pasien langsung dianggap Hadir. Nomor antrean poli terbit saat itu juga. Booking Hari Ini — pasien datang pagi tetapi dijadwalkan untuk sesi praktik nanti pada hari yang sama (mis. lansia datang pagi minta dijadwalkan sesi sore, pulang dulu). Kunjungan tersimpan dengan Status Kunjungan	P0	✓ Default mode Onsite; pasien walk-in selesai tanpa langkah tambahan. ✓ Mengaktifkan Booking membuka pemilihan tanggal lain & jam yang belum dimulai. ✓ Memilih tanggal selain hari ini otomatis mengaktifkan Booking.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
	double-book dan waktu tunggu tetap terhitung benar.	"Terjadwal"; check-in dilakukan saat pasien datang untuk sesi tersebut. Nomor antrean poli terbit saat check-in. ● Booking — pasien dijadwalkan untuk tanggal lain. Kunjungan tersimpan dengan Status Kunjungan "Terjadwal"; check-in dilakukan pada hari kedatangan. Nomor antrean poli terbit saat check-in. Alur: ● Setelah penjamin dipilih, petugas memilih jenis layanan: Klinik / Penunjang / Penunjang+Klinik. Paket MCU adalah sub-pilihan Penunjang+Klinik. ● Form pendaftaran menampilkan toggle Booking (default mati) — referensi visual: lihat mockup form Pilih Dokter. ● Bila Klinik / Penunjang+Klinik: petugas memilih poli → sistem menampilkan seluruh dokter di poli tersebut, termasuk yang tidak praktik hari ini. ● Petugas memilih dokter → sistem menampilkan jadwal praktik dokter: tanggal/hari praktik, jam praktik per sesi, dan sisa kuota per sesi. ● Petugas memilih sesi → sistem otomatis mengatur toggle Booking dan field tanggal kunjungan sesuai aturan default di bawah. ● Sistem memotong kuota saat itu juga dan membuat kunjungan dengan Jenis Pendaftaran sesuai mapping (toggle + tanggal) di bawah. ● Bila Penunjang / Penunjang+Klinik: alur penunjang berjalan paralel. Aturan toggle Booking ● Toggle Booking adalah binary (On/Off) dengan dua label visual: Off = Pendaftaran Langsung (default), On = Booking. ● Patokannya: bila sesi yang dipilih masih jauh dari jam saat ini (lebih dari sekitar 2 jam sebelum praktik mulai), sistem otomatis nyalakan toggle. Threshold ini configurable		✓ Jam yang belum dimulai dapat dipilih saat Booking aktif; jam yang sudah lewat tidak dapat dipilih. ✓ Memilih jam yang belum dimulai saat mode masih Onsite memunculkan peringatan untuk mengaktifkan Booking. ✓ Kuota terpotong saat kunjungan/booking dibuat. ✓ Daftar poli/dokter selalu sinkron dengan Facility Management; seluruh dokter poli ditampilkan, dan sesi dengan kuota habis ditandai jelas & tidak dapat dipilih. ✓ Pendaftaran ganda ke poli sama dalam satu hari mendapat dialog konfirmasi.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		per-RS sebagai master setting (default 2 jam) — detail nilai disepakati dengan RS saat go-live. Override toggle (petugas boleh ubah manual, terbatas) - Petugas hanya dapat melakukan override pada kondisi: sesi hari ini yang default Off, diubah menjadi On. Use case-nya pasien lansia datang pagi, sesi praktik sebentar lagi, tapi pasien minta pulang dulu / tidak menunggu di RS — petugas geser toggle ke On supaya kunjungan tersimpan sebagai Booking Hari Ini dan nomor antrean baru terbit saat pasien check-in. Sesi hari ini yang default On (sesi masih jauh), jika petugas mengubah ke Off. Saat ini terjadi, sistem menampilkan dialog konfirmasi: <i>"Sesi praktik masih [X] jam dari sekarang. Yakin ingin mendaftarkan pasien sebagai Pendaftaran Langsung? Pasien akan dianggap Hadir sekarang."</i> Bila petugas menekan Ya, lanjutkan, kunjungan tersimpan sebagai Pendaftaran Langsung. Bila menekan Batal, toggle kembali ke On (Booking Hari Ini). Reminder ini melindungi dari kelalaian — petugas tidak boleh tidak sadar memilih Pendaftaran Langsung untuk sesi yang masih lama, karena dampaknya laporan waktu tunggu FKRTL keliru. Case Jam Dokter 14.00 - 17.00 Aturan Toggle Booking berikut		

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		Sesi beda hari mis. Senin minggu depan Sistem default Toggle On (terkunci) ↓ Booking Status: Terjadwal Override petugas Tidak dapat di-Off-kan Sesi hari ini, dekat ≤ 2 jam dari sekarang Sistem default Toggle Off (default) ↓ Pendaftaran Langsung Status: Hadir Override petugas Geser ke On — tanpa dialog konfirmasi ↓ Booking Hari Ini Status: Terjadwal Sesi hari ini, jauh > 2 jam dari sekarang Sistem default Toggle On (default) ↓ Booking Hari Ini Status: Terjadwal Override petugas Geser ke Off — muncul dialog konfirmasi ↓ Pendaftaran Langsung Status: Hadir Garis solid = jalur default sistem · Garis putus-putus = jalur override petugas M = 30 menit N = 2 jam Sesi praktik dokter 11:30 12:00 14:00 17:00 Tertutup Buka awal Booking H.I. Jendela Langsung akan datang Sesi berlangsung sedang praktik Cutoff Toggle Booking — ON (kunci) OFF (default) OFF (default) — Jenis Pendaftaran disabled Booking H.I. Pendaftaran Langsung Pendaftaran Langsung — Status awal — Terjadwal Hadir Hadir —		

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		Default — toggle mati Booking dinyalakan Pilih Dokter ☐ Booking Pendaftaran langsung Cara Masuk Rujukan FKTP Klinik Klinik Anak Dokter dr. Galih H., Sp. A Jam Praktik · sedang berlangsung 15:01 – 17:00 Quota 5 dari 50 Kembali Lanjut Pilih Dokter ☒ Booking Pasien dijadwalkan Tanggal Kunjungan Senin, 15/06/2026 Cara Masuk Rujukan FKTP Klinik Klinik Anak Dokter dr. Galih H., Sp. A Jam Praktik · akan datang 09:00 – 12:00 Quota 3 dari 50 Kembali Lanjut Aturan slot & kuota: • Sumber kuota & jadwal dokter selalu dari Facility Management — pendaftaran tidak menyimpan jadwal sendiri. • Seluruh dokter di poli selalu ditampilkan, termasuk yang tidak praktik hari ini, agar petugas tetap dapat memilihnya untuk booking ke depan. • Petugas hanya dapat memilih dari sesi praktik yang benar-benar dimiliki dokter tersebut. Dengan begitu petugas tidak mungkin menjadwalkan pada tanggal/jam saat dokter tidak praktik, meskipun semua dokter ditampilkan. • Sesi yang belum dimulai tetap dapat dipilih saat Booking aktif (mis. pukul 08:00 boleh memilih sesi 14:00) — tidak ada penguncian berdasarkan jam berjalan. • Sesi yang sudah lewat hari ini tidak dapat dipilih (cutoff) — mis. pukul 15:00 tidak dapat memilih sesi 14:00. • Kuota dipotong saat kunjungan dibuat (termasuk Booking), bukan saat check-in — agar kursi pasien booking aman.		

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		- Sesi dengan kuota habis tetap ditampilkan namun tidak dapat dipilih (disabled + pesan "Kuota telah penuh, silakan pilih jadwal atau dokter lain"). Aturan lain: - Bila pasien sudah terdaftar ke poli yang sama pada hari yang sama, tampilkan dialog konfirmasi "Pasien sudah terdaftar di [poli] hari ini. Lanjutkan pendaftaran baru?". <i>Konteks operasional: dari 200–400 pasien RJ/hari, sekitar 60–80% memilih layanan Klinik tunggal, sisanya Penunjang atau kombinasi. Pemilihan poli/dokter adalah langkah paling sering diulang oleh petugas; UX harus dioptimalkan untuk kasus paling umum (kunjungan ulang ke poli sama dengan dokter sama).</i> <i>Konteks Operasional: dari 200–400 pasien/hari, ~60–80% memilih Klinik tunggal dan mayoritas adalah walk-in). Karena itu pendaftaran langsung dijadikan default tanpa langkah tambahan; Booking yang lebih jarang diberi satu langkah sengaja (toggle) agar petugas sadar. Case booking sore nyata di lapangan: pasien lansia tanpa Mobile JKN datang pagi untuk dijadwalkan pemeriksaan sore.</i>		
Registrasi Penunjang via Nomor Order (Re-call) <i>Hal ini didetailkan pada masing-masing pendaftaran penunjang (Pendaftaran Lab, Radiologi)</i>	Sebagai petugas, saya ingin menyambungkan pasien ke order penunjang yang sudah dibuat dokter via dropdown, meski pasien datang di luar tanggal jadwal.	Alur (pasien dengan order existing): - Setelah pasien teridentifikasi dan layanan dipilih sebagai Penunjang, sistem menampilkan daftar order penunjang milik pasien yang masih aktif/valid. - Daftar disajikan sebagai DROPDOWN dengan kolom: Nomor Order, Dokter Pengirim, Jenis Pemeriksaan, Tanggal Dibuat. Order yang sudah selesai dilayani tidak ditampilkan. - Petugas memilih order yang sesuai dengan keperluan pasien hari ini. - Pemilihan order menyambungkan pendaftaran dengan order tersebut; data pemeriksaan otomatis ter-link ke kunjungan. - Sistem menerbitkan nomor antrean penunjang. Alur (pasien tanpa order): - Bila daftar order kosong (pasien tidak punya order, atau order kedaluwarsa), petugas memilih opsi "Buat Permintaan Baru".	P 0	✓ Dropdown menampilkan order aktif milik pasien yang dipilih. ✓ Memilih order menyambungkan registrasi tanpa perlu input nomor manual. ✓ Pasien tanpa order memiliki jalur "buat permintaan baru" yang lancar. ✓ Order kedaluwarsa/selesai tidak ditampilkan di dropdown. ✓ Dropdown mendukung pencarian/filter bila daftar > 5 item.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		- Sistem menanyakan jenis permintaan: Lab Klinik atau Patologi Anatomi. - Petugas mengisi data permintaan dasar; permintaan baru tersimpan dan langsung tersambung dengan pendaftaran. Aturan: - Tidak ada lagi input nomor order manual via text — selalu via dropdown agar tidak terjadi salah-ketik. - Order dapat di-recall meskipun tanggal kunjungan berbeda dari tanggal order dibuat (mis. order 30 Mei, pasien datang 2 Juni — tetap dapat dipilih). PENGAKUAN TANGGAL untuk penagihan/klaim mengikuti modul Billing — bukan ranah pendaftaran. - Bila pasien memiliki lebih dari satu order aktif, semua ditampilkan; petugas memilih yang sesuai keperluan hari itu. <i>Konteks operasional: estimasi 15–25% pasien RJ memilih layanan penunjang; dari mereka sekitar 30–50% datang dengan order existing (sisanya order baru di tempat). Pain point v1 “input nomor manual menyusahkan” adalah keluhan langsung dari petugas — dropdown wajib mendukung pencarian/filter agar daftar panjang tidak menghambat.</i>		
Generate Antrean Poli	Sebagai petugas/pasien, saya ingin mendapat nomor antrean poli secara otomatis, agar urutan pemanggilan di poli rapi.	Alur: - Setelah seluruh data pendaftaran tersimpan (penjamin, layanan, penunjang bila ada), sistem menerbitkan nomor antrean poli untuk kunjungan tersebut. - Format nomor antrean: Kode Poli + Nomor Urut (mis. KP-001 untuk Klinik Paru antrean ke-1 hari itu). - Untuk pasien walk-in/onsite, nomor antrean langsung terbit dan dicetak pada slip yang diberikan ke pasien. - Untuk pasien booking, yang tercetak saat booking adalah bukti booking (berisi tanggal, jam, dokter); nomor antrean poli baru terbit saat pasien check-in di hari-H. Ini menjaga urutan pemanggilan tetap mengikuti kedatangan. - Kartu/Slip antrean dapat dicetak ulang dari dashboard bila diperlukan. Aturan: - Nomor antrean unik per poli per hari, berurutan otomatis.	P 0	- Nomor antrean poli terbit otomatis untuk pasien walk-in setelah pendaftaran tersimpan. - Pasien booking menerima bukti booking; nomor antrean poli terbit saat check-in. - Nomor antrean unik per poli per hari dan berurutan. - Pasien prioritas mendapat penanda pada nomor antrean. - Kartu/Slip antrean dapat dicetak ulang melalui dashboard.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		- Format kode poli dapat dikonfigurasi per-RS (master setting). - Nomor antrean poli diterbitkan saat kunjungan berstatus Hadir — untuk walk-in terjadi langsung, untuk booking terjadi saat check-in. - Pasien dengan penanda prioritas mendapat nomor antrean dengan penanda khusus agar pemanggilan poli memprioritaskannya. Konteks Operasional: dari 200–400 pasien/hari, mayoritas walk-in dan langsung mendapat nomor antrean. Karena nomor untuk booking baru terbit saat kedatangan, urutan pemanggilan poli tidak terganggu oleh kunjungan yang dijadwalkan jauh hari. Notes : rencana akan ada antrean pendaftaran yang berbeda dengan antrean poli		
Check-in (Kehadiran Pasien)	Sebagai petugas, saya ingin menandai kehadiran pasien dan merekam waktu kedatangannya secara benar, agar waktu tunggu terukur akurat dan pasien masuk antrean poli pada saat yang tepat.	Pembuatan kunjungan — saat data pendaftaran tersimpan. Bisa hari ini (walk-in/onsite) atau jauh hari (booking). Check-in — saat pasien benar-benar hadir di RS untuk sesinya. Sistem menyimpan dua waktu terpisah: waktu_pembuatan_kunjungan dan waktu_kedatangan. Check-in hanya mengisi waktu_kedatangan dan tidak mengubah waktu pembuatan kunjungan. Kapan pasien tercatat check-in: Walk-in/Onsite — otomatis Hadir begitu pendaftaran selesai; waktu_kedatangan = waktu pendaftaran selesai. Booking sore (hari yang sama) — berstatus Terjadwal sejak pagi; check-in saat pasien datang untuk sesi sore. Booking beda hari — berstatus Terjadwal; check-in pada hari kedatangan. Booking Mobile JKN (MJKN) — pasien booking sendiri lewat aplikasi (hari sama atau beda hari); ter-check-in saat pasien check-in mandiri di aplikasi MJKN atau di-check-in petugas saat datang (akan dibahas detail di case integrasi)		✓ waktu_pembuatan_kunjungan dan waktu_kedatangan tersimpan sebagai dua kolom terpisah. ✓ Pasien walk-in onsite (semua penjamin) langsung berstatus Hadir saat pendaftaran selesai. ✓ Pasien booking berstatus Terjadwal dan menjadi Hadir hanya setelah check-in pada hari sesinya. ✓ Check-in tidak dapat dilakukan sebelum hari sesi kunjungan. ✓ Saat pasien booking check-in, nomor antrean poli terbit.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		Alur: - Pasien walk-in: saat pendaftaran selesai, kunjungan langsung berstatus Hadir dan waktu_kedatangan terisi otomatis. - Pasien booking: saat datang pada hari/sesinya, petugas menekan Check-in; status berubah menjadi Hadir, waktu_kedatangan terisi, dan nomor antrean poli terbit Aturan: waktu_kedatangan selalu berbeda dari waktu_pembuatan_kunjungan; disimpan terpisah dan tidak saling menimpa. - Check-in hanya dapat dilakukan pada hari sesi kunjungan; tidak dapat check-in lebih awal dari hari-H. - Batas waktu mulai check-in sebelum jam sesi mengikuti keputusan operasional - Di Phase 1, check-in dilakukan di loket oleh petugas; check-in mandiri via APM Konteks Operasional: waktu tunggu adalah indikator kepatuhan FKRTL yang dilaporkan ke BPJS, dihitung dari waktu_kedatangan. Bila pasien booking sore tercatat hadir sejak pagi (seperti v1), angka waktu tunggu menjadi keliru. Memisahkan check-in dari pembuatan kunjungan menutup celah ini. Status Kunjungan & Jenis Pendaftaran Konsep: tiap kunjungan punya dua atribut terpisah (lihat Glossary) Jenis Pendaftaran (cara masuk) — Reguler / Booking / Mobile JKN / Rujukan Internal. Ditetapkan saat kunjungan dibuat, relatif tetap. Status Kunjungan (siklus hidup) — Terjadwal / Hadir / Selesai / Dibatalkan. Berubah seiring proses. Transisi Status Kunjungan (kapan berubah & pemicunya):		

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		• Saat kunjungan dibuat: walk-in/onsite → langsung Hadir; booking → Terjadwal. • Terjadwal → Hadir: saat pasien check-in (Fitur 11b). • Hadir → Selesai: setelah layanan di poli selesai (update dari modul pelayanan; pendaftaran menerima statusnya). • Terjadwal / Hadir → Dibatalkan: lewat Batal Pasien		
Consent Berlapis (UU PDP)	Sebagai RS, saya ingin memenuhi UU PDP dengan consent terpisah & eksplisit, agar terhindar dari temuan audit & sanksi.	Alur General Consent: • Sistem menampilkan permintaan general consent SAAT: (a) pasien baru pertama kali daftar; (b) pasien lama membuka jenis layanan baru (mis. dari RJ ke RI); (c) versi general consent berubah (RS me-rilis versi baru). • Petugas/pasien membaca consent (tersedia bahasa lokal); pasien menandatangani secara fisik (paper) atau elektronik (signature pad/touchscreen, opsional). • Sistem menyimpan record consent: versi consent, waktu, ID petugas saksi, ID pasien. • Selama versi consent belum berubah dan tipe layanan tidak berubah, sistem TIDAK meminta ulang general consent pada kunjungan berikutnya. Part integrasi satu sehat next di integrasi Alur Consent Data Spesifik (SATUSEHAT): • Consent untuk data spesifik dibuat SEBAGAI PERMINTAAN TERPISAH dari general consent — tidak boleh di-bundle/di-default-checked. (<i>perlu koordinasi dengan Squad integrasi mengenai hal ini</i>) • Penolakan tidak memblokir layanan inti: pasien yang menolak consent SATUSEHAT tetap mendapat seluruh layanan RS (yang bersandar dasar hukum lain selain consent). • Penolakan hanya mematikan pemrosesan sekunder yang membutuhkan dasar consent (mis. pengiriman data ke SATUSEHAT untuk pasien tersebut). Aturan: • Consent data spesifik WAJIB terpisah & eksplisit — ini ketentuan UU PDP. Pelanggaran dapat menyebabkan temuan audit & sanksi (denda hingga 2% pendapatan tahunan).	P0	✓ General consent diminta tepat pada 3 kondisi: pasien baru, layanan baru, versi berubah. ✓ Consent data spesifik tampil sebagai item terpisah, tidak default-checked. ✓ Penolakan consent data spesifik tidak memblokir layanan inti. ✓ Seluruh record consent menyimpan versi/waktu/petugas/pasien. ✓ Versi consent dapat di-update tanpa kehilangan riwayat consent versi lama.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		Setiap perubahan status consent (granted/withdrawn) tercatat audit lengkap. Konteks operasional: setiap pasien baru dan setiap pertama kali masuk jenis layanan baru = 1 consent. Estimasi 20–40 general consent baru per hari di MVP. Alur consent yang lambat = bottleneck baru di loket; desain harus efisien (signature pad atau template cepat).		
Data Sosial & Hak Akses (v1)	Sebagai petugas berwenang, saya ingin melihat/mengubah data sosial pasien sesuai hak akses saya.	Alur: - Pada profil pasien, tersedia tab/section “Data Sosial” yang menampilkan: identitas lengkap, demografi, kontak, agama, etnis, bahasa, hambatan komunikasi, disabilitas, penanggung jawab, dll. - Akses tampilan: seluruh role pendaftaran (Role 1 & 2). - Akses edit: hanya role berwenang sesuai konfigurasi hak akses (di V1 semua role masih bisa, harapannya khusus role2 pendaftaran, RM, administrator) - Setiap perubahan field tercatat audit: field apa, nilai sebelum, nilai sesudah, petugas, waktu. Aturan: - Hak akses edit Data Sosial (Role 1 = edit; Role 2 = view-only, atau sesuai matriks RS). - Field yang dapat diedit configurable per-role. - Untuk field sensitif (NIK, nama lengkap, tanggal lahir) yang berdampak pada identitas pasien, edit memerlukan otorisasi tambahan dari Kepala RM — lihat fitur Merge/Unmerge & Roles. Konteks operasional: Data Sosial dibuka oleh hampir setiap kunjungan lama untuk verifikasi/pelengkapan (estimasi 60–80% kunjungan = pasien lama). Halaman ini harus loading cepat (≤ 1 detik) dan mendukung edit inline tanpa modal panjang.	P 1	✓ Data Sosial tampil lengkap untuk semua role pendaftaran. ✓ Edit terbatas pada role berwenang sesuai konfigurasi. ✓ Setiap perubahan tercatat audit dengan nilai sebelum/sesudah. ✓ Edit field sensitif memerlukan otorisasi tambahan.
Batal Pasien (v1)	Sebagai petugas pendaftaran, saya ingin membatalkan registrasi yang salah, dengan jejak audit lengkap.	Alur: - Pada dashboard pendaftaran, setiap pasien terdaftar memiliki tombol “Batal Periksa” - Saat ditekan, sistem menampilkan dialog konfirmasi yang meminta: (a) alasan pembatalan (mandatory, dropdown + free text); (b) konfirmasi ulang dari Administrator.	P 1	✓ Hanya Administrator yang dapat membatalkan pendaftaran. ✓ Setiap pembatalan tercatat audit lengkap dengan alasan. ✓ Pembatalan adalah soft delete; histori tetap dapat ditelusuri.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		- Setelah dikonfirmasi: status kunjungan diubah ke "Dibatalkan". Nomor antrean dihapus dari antrean aktif poli. - Tindakan tercatat audit: pasien, kunjungan, alasan, petugas, waktu. Aturan: - Pembatalan dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki akses (petugas pendaftaran, administrator) - Pembatalan TIDAK menghapus record (soft delete); kunjungan tetap ada di histori dengan status Dibatalkan. - Alasan pembatalan wajib diisi dengan pilihan terstandar (mis. "Pasien mundur", "Kesalahan input", "Dokter tidak praktik", dll) plus catatan bebas opsional. - Bila pembatalan terjadi setelah SEP/dokumen klaim diterbitkan, sistem memberi peringatan dan mengarahkan koordinasi ke modul Billing. <i>Konteks operasional: estimasi pembatalan 1–3% dari kunjungan harian, namun pembatalan tanpa kontrol = celah audit & potensi penyalahgunaan (mis. menghapus jejak salah daftar). Hak akses terbatas adalah kontrol kuat.</i>		✓ Peringatan koordinasi muncul bila SEP/dokumen klaim sudah terbit.
Riwayat Pembatalan Pasien	Sebagai petugas/administrator, saya ingin melihat daftar pasien yang pendaftarannya dibatalkan beserta alasan dan pelakunya, agar saya dapat memantau pembatalan dan tidak bingung mencari pasien yang hilang dari daftar aktif.	Alur: - Petugas membuka layar/tab "Riwayat Pembatalan Pendaftaran". - Sistem menampilkan daftar kunjungan berstatus Dibatalkan, dengan kolom: No. Antrean, No. Pendaftaran, No. RM, Nama, No. SEP (Phase 2), NIK, Klinik, Alamat, Cara Pembayaran, Dibatalkan Oleh, Dibatalkan Pada (tanggal & waktu), dan Alasan Pembatalan. - Petugas dapat menyaring berdasarkan rentang tanggal, dan membuka detail satu record (read-only). Aturan: - Layar ini read-only; di sini hanya pemantauan.		✓ Daftar kunjungan berstatus Dibatalkan tampil dengan kolom lengkap termasuk Dibatalkan Oleh, Dibatalkan Pada, dan Alasan. ✓ Dapat disaring berdasarkan rentang tanggal. ✓ Layar bersifat read-only; record berasal dari soft delete Fitur 13. ✓ Detail tiap record dapat dibuka untuk penelusuran.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		- Sumber data: kunjungan berstatus Dibatalkan (soft delete) — record tidak hilang, hanya keluar dari daftar aktif dashboard. - Menampilkan jejak audit pembatalan (pelaku, waktu, alasan) agar transparan dan tidak menimbulkan kebingungan ("ke mana pasien ini?"). - Akses sesuai hak: petugas pendaftaran & administrator. Konteks Operasional: estimasi pembatalan 1–3% kunjungan harian. Tanpa layar pemantau, pasien yang dibatalkan "menghilang" dari daftar aktif dan petugas bingung menelusurinya; riwayat ini menjadikan pembatalan transparan dan dapat diaudit.		
Export & Print (v1)	Sebagai petugas, saya ingin mengunduh & mencetak riwayat kunjungan dan surat kontrol.	Alur Export Riwayat: - Pada dashboard, petugas membuka menu "Export Riwayat". - Petugas memilih rentang tanggal (maksimal 90 hari). - Sistem menghasilkan file dengan field standar: No. Registrasi, No. RM, Nama, Jenis Kelamin, Alamat, Tanggal Kunjungan, Poli, Dokter, Diagnosa (1–4) + ICD-10, Tindakan (1–2) + ICD-9, Status, Obat. - Format default: .pdf. Format tambahan (CSV/Excel) bila dibutuhkan RS. - File diunduh ke perangkat petugas; tidak meninggalkan jejak di sistem (file dianggap rilis ke petugas). Alur Export Surat Kontrol: - Petugas membuka menu "Export Surat Kontrol". - Petugas memilih rentang tanggal. - Sistem mengumpulkan seluruh surat kontrol pada rentang tersebut menjadi satu folder .zip. - Format nama file: SURAT_KONTROL_DD_MM_YYYY.zip (mengikuti praktik v1). - Setiap surat di dalam .zip adalah file .pdf individual. Alur Print: - Tombol "Print" tersedia di detail kunjungan untuk mencetak: slip antrean (ulang), bukti pendaftaran, surat kontrol, SEP (Phase 2), dokumen jaminan (Asuransi). - Setiap dokumen mengikuti template per-RS yang configurable.	P 1	✓ Export Riwayat menghasilkan file dengan field standar dalam rentang ≤ 90 hari. ✓ Export Surat Kontrol menghasilkan .zip berisi file .pdf individual. ✓ Print dokumen mengikuti template per-RS. ✓ Durasi export ≤ 3 menit untuk rentang penuh.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		Aturan: - Rentang maksimum export 90 hari — mencegah beban server berlebih dan menjaga kepatuhan privacy. - Export besar (mendekati 90 hari & data padat) dijamin selesai dalam ≤ 3 menit. - Akses export terbatas pada role berwenang. <i>Konteks operasional: Export riwayat dipakai untuk laporan harian/mingguan ke manajemen RS dan audit BPJS. Frekuensi: harian (untuk operasional) hingga bulanan (untuk laporan).</i>		

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
Dashboard Pendaftaran (Daftar Pasien & Filter)	Sebagai petugas, saya ingin melihat daftar pasien yang terdaftar hari ini lengkap dengan filter dan aksi cepa	Dashboard ini adalah log aktivitas pendaftaran — memantau "siapa yang sudah/sedang didaftar hari ini" dan titik mulai semua aksi (tambah pendaftaran, check-in, cetak, batal, buka detail). Memanggil/melewati antrean dilakukan di layar terpisah (lihat catatan "Antrean Pendaftaran" di akhir fitur ini). Alur: - Saat petugas membuka modul Pendaftaran RJ, sistem menampilkan daftar pasien terdaftar dengan tanggal default hari ini. - Petugas dapat mempersempit daftar lewat filter, mencari pasien lewat kolom pencarian, atau menambah pendaftaran baru lewat tombol tambah. - Tiap baris menyediakan aksi: check-in, cetak/cetak ulang slip, batal, dan buka detail kunjungan. Filter (dipertahankan dari v1 + tambahan): - Dipertahankan dari v1: Jenis Pasien (Baru/Lama), Cetak Antrean, Fingerprint, SEP, Tanggal (default hari ini), Dokter, Klinik.	P0	✓ Dashboard menampilkan daftar pasien terdaftar dengan tanggal default hari ini. ✓ Seluruh filter v1 dipertahankan, ditambah filter Jenis Pendaftaran dan Status Kunjungan. ✓ Seluruh kolom v1 dipertahankan, dengan Jenis Pendaftaran dan Status Kunjungan tampil terpisah. ✓ Urutan default terbaru di atas; kolom dapat diurutkan ulang. ✓ Jumlah baris per halaman dapat dipilih (25/50/100/Semua) ✓ Pasien prioritas ditandai jelas secara visual. ✓ Tersedia aksi per baris: check-in, cetak/cetak ulang, batal, buka detail; serta tombol tambah pendaftaran dan kolom pencarian.

Fitur	User Story	Criteria Details	P	Acceptance Criteria
		Tambahan baru: Jenis Pendaftaran (Reguler / Booking / Mobile JKN / Rujukan Internal) dan Status Kunjungan (Terjadwal / Hadir / Selesai / Dibatalkan). Kolom tabel (dipertahankan dari v1 + tambahan): - Dipertahankan dari v1: No, No Antrean, No Pendaftaran, No RM, Nama, No SEP, Klinik, Alamat, Cara Pembayaran, Jenis Pasien (Baru/Lama), Status, Cetak, MJKN, Check-in. Tambahan/penegasan: kolom Jenis Pendaftaran dan Status Kunjungan ditampilkan terpisah (menggantikan kolom "Status" lama yang bermakna ganda). Penyesuaian tata letak/UX kolom menyusul saat desain. - Catatan: kolom No SEP, MJKN, dan filter Fingerprint baru terisi saat jalur BPJS/MJKN aktif (Phase 2); di Phase 1 ditampilkan kosong/—. Aturan: Urutan default: terbaru di atas (pasien yang baru didaftar muncul paling atas) — sesuai fungsi log aktivitas. Kolom dapat diurutkan ulang oleh petugas. Jumlah baris per halaman dapat dipilih: 25 / 50 / 100 / Semua, default 50. Default ini menjaga performa di jam sibuk; "Semua" tersedia bila petugas memerlukannya. - Pasien dengan penanda prioritas (skrining batuk positif, lansia, disabilitas) ditandai jelas secara visual di mana pun posisinya pada daftar. - Dashboard memantau & menindaklanjuti; memanggil antrean bukan fungsi dashboard ini (ada di layar Antrean Pendaftaran). - Tombol Export mengikuti detail yang sudah dimention di fitur export		

Validasi

Daftar validasi field/aturan yang harus ditegakkan sistem, beserta pesan error yang ditampilkan ke pengguna.

Fitur/Proses	Kondisi	Message
NIK (KTP)	User menginputkan kurang atau lebih dari 16 digit	"NIK tidak valid. Harus 16 digit angka."
Bridging Disudkapil	NIK tidak ditemukan / API timeout	"Data NIK tidak ditemukan atau koneksi terganggu. Silakan lanjut input manual; NIK akan divalidasi otomatis saat koneksi pulih."
Field Mandatory	User tidak mengisi field wajib	Pesan pada masing-masing field, mis: "Nama lengkap wajib diisi", "Dokter wajib dipilih"
Email	Format email tidak sesuai	"Format email tidak valid"
Validasi Panjang Data	User menginputkan data melebihi panjang maksimum	Validasi sistem terkait length data sesuai aturan field
Pemilihan Dokter	Dokter tidak praktik pada poli/tanggal terpilih	"Dr. [Nama] tidak praktik pada [tanggal]. Silakan pilih jadwal atau dokter lain."
Kuota Dokter Habis	Slot harian dokter sudah penuh	Tombol Lanjut disabled + pesan: "Kuota dokter telah penuh. Silakan pilih dokter atau jadwal lain."
NIK Duplikat	NIK sudah digunakan pasien lain	"NIK sudah terdaftar atas nama [nama pasien]. Apakah ini pasien yang sama?" dengan opsi: Ya (lanjut ke pasien existing) / Tidak (tinjau ulang)
Skrining Batuk	Belum dijawab sebelum lanjut ke pilih layanan	"Skrining batuk wajib diisi sebelum melanjutkan."
Consent Belum Direkam	Pasien baru / layanan baru tanpa general consent	"General consent belum direkam untuk pasien/layanan ini. Silakan rekam sebelum melanjutkan."

Case

Skenario penting yang harus ditangani sistem beserta mitigasi yang direncanakan.

No	Case	Dampak	Mitigasi
1	Duplikasi rekam medis terdeteksi	Risiko double record menyebabkan riwayat klinis terpecah	Tampilkan dialog kandidat existing; petugas memutuskan: gunakan existing / buat baru (wajib alasan) / koreksi data.
2	NIK sudah digunakan pasien lain	Potensi identity theft atau kesalahan data entry sebelumnya	Tampilkan alert: "NIK sudah terdaftar atas nama [nama pasien]." Petugas verifikasi langsung dengan pasien.

No	Case	Dampak	Mitigasi
3	Kuota dokter sudah penuh (0 tersisa)	Pasien tidak dapat mendaftar ke dokter tersebut	Tombol Lanjut disabled; tampilkan pesan + sarankan dokter/jadwal alternatif.
4	Pasien sudah terdaftar di poli yang sama hari ini	Potensi duplikasi kunjungan yang tidak perlu	Tampilkan pesan: "Pasien sudah terdaftar di [poli] hari ini. Lanjutkan pendaftaran baru?"
5	Layanan luar (BPJS/Disdukcapil/SAT USEHAT) down saat pendaftaran	Bila memblok = loket berhenti; bila tidak ditangani = data tidak tersinkron	Terima-lalu-rekonsiliasi: pendaftaran tetap lanjut; record ditandai "menunggu sinkron" + masuk daftar kerja petugas; retry otomatis.
6	Pasien dengan penanda Skrining Batuk Positif di area umum	Risiko penularan TB ke pasien & petugas lain	Penanda diteruskan ke poli; pasien diarahkan masker + ruang tunggu terpisah + prioritas antrean.
7	Pasien tanpa identitas (bayi baru lahir, WNA, tak dikenal)	Bila ditolak = pelanggaran standar layanan	Identitas Fleksibel: dapat diinput tanpa identitas ;pasien tetap dilayani penuh
8	Ganti penjamin di tengah kunjungan (Umum→BPJS)	Bila syarat penjamin baru kurang (mis. SEP belum dibuat) = klaim gagal	Guard-aware: sistem evaluasi delta kewajiban; arahkan ke langkah yang kurang sebelum menyimpan; tidak boleh simpan-paksa.
9	Pasien menolak consent SATUSEHAT	Bila memblok layanan = pelanggaran UU PDP	Penolakan tidak memblok layanan inti; data pasien TIDAK dikirim ke SATUSEHAT; status ditandai jelas.
10	APM down atau koneksi terganggu	Pasien tidak dapat check-in mandiri	Fallback ke loket; petugas siaga di area APM untuk membantu pasien yang kesulitan.

Data Requirement

No	Data	Keterangan
A. Dashboard Data Pendaftaran Pasien Rawat Jalan		
A.1 Filter		
1	Jenis Pasien	○ Single dropdown ○ Pilihan → ○ Semua pasien ○ Pasien baru ○ Pasien lama ○ Default: Semua pasien
2	Cetak Antrean	○ Single dropdown ○ Pilihan → ○ Semua ○ Belum dicetak ○ Sudah dicetak ○ Default: Semua
3	Fingerprint	○ Single dropdown ○ Pilihan → ○ Semua ○ Sudah ○ Belum ○ Default: Semua
4	SEP	○ Single dropdown ○ Pilihan → ○ Semua ○ Sudah ○ Belum ○ Default: Semua

5	Tanggal	- o Date - o Format: DD-MM-YYYY - o Default: Hari ini
6	Dokter	- o Single dropdown - o Pilihan: Semua dokter → Sumber data dari master data staf - o Default: Semua dokter
7	Unit/Klinik	- o Single dropdown - o Pilihan: Semua unit, Klinik Paru, Klinik Kebidanan, dll → Sumber data dari master data unit - o Default: Semua unit
8	Jenis Pendaftaran	- o Single dropdown - o Pilihan: Semua, Reguler, Booking, Mobile MJKN, Rujukan Internal - o Default: Semua
9	Status Kunjungan	- o Single dropdown - o Pilihan: Semua, Terjadwal, Hadir, Selesai, Dibatalkan - o Default: Semua
10	Seach	- o Search → - o No RM - o Nama Pasien - o Alamat

A.2 Kolom Table

1	No	- o Generate by sistem - o Nomor urutan - o Read-only
1	Tanggal & Waktu Pendaftaran	- o Format: HH:MM WIB - o DD-MM-YYYY - o Read-only
2	No Antrean	- o Generate sistem per poli/hari - o Format: Kode Unit - 001 (auto-increment) - o Example: KP-001 - o Read-only

3	No RM	○ Generate sistem ○ Auto increment ○ Format → 6 digit ○ Example → 000001 ○ Read-only
4	Nama	○ Sumber Data → Sesuai data detail data sosial pasien - Nama Lengkap ○ Terdapat icon fingerprint menandakan status verifikasi biometrik ○ Terdapat icon prioritas jika Kartu Prioritas = Ada, kunjungan ditandai prioritas ○ Read-only
5	No Pendaftaran	○ Generate sistem ○ Auto increment ○ Format → 6 digit ○ Example → 000001 ○ Read-only
6	NIK	○ Sumber Data → Sesuai data detail data sosial pasien - Jenis Identitas & Nomor Identitas ○ Format: 16 digit angka ○ Read-only
7	No Kartu	○ Sumber Data → Sesuai data detail data sosial pasien - nomor kartu BPJS ○ Format: 13 digit angka ○ Read-only
8	Nama Dokter	○ Sumber Data → Sesuai data detail data dokter yang dipilih ○ Read-only
9	Klinik	○ Sumber Data → Sesuai data layanan klinik tujuan ○ Read-only
10	Cara Pembayaran	○ Sumber Data → Sesuai data tipe penjamin ○ Editable
11	Jenis Pasien	○ Sumber Data → Status identifikasi pasien ○ Badge: Baru / Lama ○ Read-only
12	Jenis Pendaftaran	○ Read-only ○ Jenis Pendaftaran →

		○ Rujuk Internal → Trigger ketika pasien tsb melalui rujuk internal ○ Reguler → Trigger ketika pasien tsb melalui onsite/walk-in ○ Booking → Trigger ketika pasien tsb melalui booking ○ Mobile MJKN → Trigger ketika pasien tsb melalui mobile JKN
13	Status Kunjungan	○ Read-only ○ Status Kunjungan → ○ Terjadwal → Trigger ketika pasien tsb booking ○ Hadir → Trigger ketika pasien tsb onsite/walk-in/check-in ○ Selesai → Trigger setelah layanan di poli selesai (update dari modul pelayanan; pendaftaran menerima statusnya). ○ Dibatalkan → Trigger ketika batal periksa
14	Cetak	○ Sumber Data → ○ Read-only
15	MJKN	○ Sumber Data → ○ Read-only
16	Check-in	○ Sumber Data → ○ Read-only
17	Batal Periksa	○ Button Batal Periksa
A.3. Batal Periksa		
1	Alasan Batal	○ Text Input ○ Mandatory ○ Hanya sekali inputan ○ Tipe data → Varchar (255)
B. Tambah Pendaftaran Pasien Rawat Jalan		
B.1. Tambah Pasien Lama → Section Pencarian Data Pasien		
1	No RM	○ Sumber Data → No RM pasien lama yang sudah tersimpan di database

2	Nama Pasien	○ Sumber Data → Nama pasien lama yang sudah tersimpan di database
3	NIK	○ Sumber Data → NIK pasien lama yang sudah tersimpan di database
4	Tanggal Lahir	○ Sumber Data → Tanggal lahir pasien lama yang sudah tersimpan di database
5	Alamat	○ Sumber Data → Alamat pasien lama yang sudah tersimpan di database

B.2. Tambah Pasien Baru dan Pasien Lama → Section Informasi Pribadi

1	No RM	○ Auto generate by sistem → Not Editable ○ Format: 6 digit angka ○ Example: 000001 ○ Auto increment ○ Tipe data → Varchar (10) ○ Read-only
2	Nomor Kartu BPJS	○ Tipe data → Varchar (20) ○ Max Varchar → 20 ○ Min Varchar → 0 ○ Numerik input ○ Opsional ○ Unique (tidak boleh ada duplikasi value dalam sistem) ○ Tidak boleh desimal ○ Bridging ke BPJS ○ Noka BPJS → 13 digit angka ○ Editable
3	NIK	○ Tipe data → Varchar (20) ○ Max Varchar → 20 ○ Min Varchar → 0 ○ Opsional ○ Tidak boleh ada duplikasi NIK ○ NIK → 16 digit angka ○ Bridging ke SATUSEHAT ○ Bridging ke Disdukcapil ○ Editable

4	Jenis Identitas	- o Tipe data → Enum - o Editable - o Opsional - o Single select dropdown - o Pilihan: - o Tidak Ada Identitas - o SIM - o KIA - o KK - o Passport - o KITAS
5	Nomor Identitas	- o Tipe data → Varchar (20) - o Max Varchar → 20 - o Min Varchar → 0 - o Opsional - o Tidak boleh ada duplikasi NIK - o NIK → 16 digit angka - o Bridging ke SATUSEHAT - o Bridging ke Disdukcapil - o Editable
6	Nama Lengkap	- o Text Input - o Tipe data → Varchar (255) - o Mandatory → Beri tanda (*) merah - o Editable
7	Status Pasien	- o Mandatory → Beri tanda (*) merah - o Single select dropdown - o Pilihan: - o Tuan - o Nyonya - o Nona - o Saudara - o Bayi - o Anak - o Tipe data → Enum - o Editable
8	Jenis Kelamin	o Radio Button Input

		○ Default null/kosong ○ Pilihan → ○ Laki-laki ○ Perempuan ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Enum ○ Editable
9	Tanggal Lahir	○ Datepicker Input ○ Format Data → DD/MM/YYYY ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Date ○ Editable
10	Usia	○ Autofill dari perhitungan input tanggal lahir ○ Tipe data → Int ○ Example: 29 Tahun ○ Read-only
11	Provinsi	○ Single select dropdown ○ Sumber data → Master data wilayah → table provinsi ○ Opsional ○ Tipe data → UUID atau Varchar (255) ○ Editable
12	Kabupaten	○ Single select dropdown ○ Sumber data → Master data wilayah → table kabupaten ○ Opsional ○ Tipe data → UUID atau Varchar (255) ○ Editable
13	Kecamatan	○ Single select dropdown ○ Sumber data → Master data wilayah → table kecamatan ○ Opsional ○ Tipe data → UUID atau Varchar (255) ○ Editable
14	Kelurahan	○ Single select dropdown ○ Sumber data → Master data wilayah → table kelurahan ○ Opsional

		- o Tipe data → UUID atau Varchar (255) - o Editable
15	Alamat Lengkap	- o Model Input: - o Value Input ■ Provinsi → Kabupaten/Kota → Kecamatan → Kelurahan - o Textarea ■ Max Char → 200 ■ Freetext - o Mandatory - o Sumber Data → Master Data Wilayah: - o Provinsi - o Kabupaten/Kota - o Kecamatan - o Kelurahan - o Mandatory → Beri tanda (*) merah - o Tipe data → Varchar (255) - o Editable
16	Agama	- o Single select dropdown - o Pilihan → - o Budha - o Hindu - o Islam - o Katolik - o Konghucu - o Kristen - o Mandatory → Beri tanda (*) merah - o Tipe data → Enum - o Editable
17	No Telepon	- o Numerik Input - o Tipe data → Varchar (20) - o Mandatory → Beri tanda (*) merah - o Format: Awali nomor telepon dengan angka 0 - o Example: 081290908890 - o Editable
18	Kartu Prioritas	- o Radio button input - o Default "Tidak" - o Pilihan →

		○ Tidak ○ Ada ○ Opsional ○ Tipe data → Boolean ○ Editable
19	Nomor Kartu Prioritas	○ Field ini muncul jika kartu prioritas "Ada" ○ Tipe data → Varchar (20) ○ Opsional ○ Text input ○ Editable
20	Golongan Darah	○ Single select dropdown ○ Pilihan: ○ A ○ B ○ O ○ AB ○ Tidak Tahu ○ Optional ○ Tipe data → Enum ○ Editable
21	Email	○ Text Input ○ Tipe data → Varchar (255) ○ Opsional ○ Email Format Validation → contoh@gmail.com ○ Jika tipe penjamin == BPJS maka akan menjadi mandatory dan jika null maka untuk dikirim ke BPJS default email contoh saja ○ Editable
22	Pendidikan	○ Single select dropdown ○ Pilihan: ○ Tidak Sekolah ○ TK ○ SD ○ SMP ○ SMA ○ Diploma I ○ Diploma II ○ Diploma III

		◦ Diploma IV ◦ Sarjana ◦ Magister ◦ Doktor ◦ Profesor ◦ Opsional ◦ Tipe data → Enum ◦ Editable
23	Pekerjaan	◦ Text input ◦ Opsional ◦ Tipe data → Varchar (100) ◦ Editable
24	Status Kawin	◦ Single select dropdown ◦ Pilihan: ◦ Belum Kawin ◦ Kawin ◦ Duda ◦ Janda ◦ Mandatory → Beri tanda (*) merah ◦ Tipe data → Enum ◦ Editable
25	Nama Ayah	◦ Text Input ◦ Tipe data → Varchar (255) ◦ Opsional ◦ Editable
26	Nama Ibu	◦ Text Input ◦ Tipe data → Varchar (255) ◦ Opsional ◦ Editable
27	Etnis	◦ Single select dropdown ◦ Pilihan: ◦ Suku Bali ◦ Suku Banjar ◦ Suku Batak ◦ Suku Betawi

		- o Suku Bugis - o Suku Cina, RRC, Taiwan - o Suku Cirebon - o Suku Dayak - o Suku Gorontalo - o Suku Jawa - o Suku Madura - o Suku Makassar - o Suku Melayu - o Suku Minahasa - o Suku Minangkabau - o Suku Nias - o Suku Sasak - o Suku Asal Aceh - o Suku Asal Banten - o Suku Asal Kalimantan Lainnya - o Suku Asal Maluku - o Suku Asal Nusa Tenggara Timur - o Suku Asal Papua - o Suku Asal Sulawesi Lainnya - o Suku Asal Sumatra Lainnya - o Suku Luar Negeri - o Suku Asal Jambi - o Suku Asal Lampung - o Suku Asal Sumatra Selatan - o Suku Nusa Tenggara Barat Lainnya - o Suku Sunda - o Mandatory → Beri tanda (*) merah - o Tipe data → Enum - o Editable
28	Bahasa yang dikuasai	- o Text Input - o Tipe data → Varchar (255) - o Mandatory → Beri tanda (*) merah - o Editable
29	Hambatan dalam Berkomunikasi	- o Single select dropdown - o Pilihan: - o Tidak Ada - o Bahasa - o Lingkungan

		○ Fisik ○ Psikologi ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Enum ○ Editable
30	Penyanggang Disabilitas	○ Single select dropdown ○ Pilihan: ○ Tidak Ada ○ Penyanggang Cacat Fisik ○ Penyanggang Cacat Mental ○ Penyanggang Cacat Fisik dan Mental ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Enum ○ Editable
B.3. Tambah Pasien Baru dan Pasien Lama → Section Layanan Klinik		
1	Tipe Penjamin	○ Single select dropdown ○ Pilihan: ○ BPJS → Mengarahkan ke alur verifikasi BPJS dan penerbitan SEP ○ Asuransi Swasta (?) ○ Asuransi Pemerintah (?) ○ Umum ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Enum ○ Editable
2	Nama Asuransi	○ Jika tipe penjamin == Asuransi maka input nama asuransi dan nomor asuransi ○ Single select dropdown ○ Sumber data → Master data tipe penjamin (?) ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Varchar (255) atau UUID ○ Editable
3	Nomor Asuransi	○ Jika tipe penjamin == Asuransi maka input nama asuransi dan nomor asuransi ○ Text input ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Varchar (20) ○ Editable

4	Layanan	○ Single select dropdown ○ Pilihan: ○ Klinik ○ Penunjang ○ Penunjang dan Klinik ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Enum ○ Editable
5	Toogle Booking	○ Toogle On/Off Booking ○ Tipe Data → Boolean ○ Editable
6	Cara Masuk	○ Single select dropdown ○ Pilihan: ○ Rujukan FKTP ○ Rujukan FKRTL ○ Rujukan Spesialis ○ Rujukan Fasilitas Rehab ○ Rujukan Panti Jompo ○ Rujukan dari RS Jiwa ○ Dari Rawat Jalan ○ Dari Rawat Inap ○ Lahir di RS ○ Lain-lain ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Enum ○ Editable
7	Klinik	○ Single select dropdown ○ Sumber data → Master data unit ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Varchar (255) atau UUID ○ Editable
8	Dokter	○ Single select dropdown ○ Sumber data → Master data jadwal dokter (?) ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Varchar (100) atau UUID ○ Editable

9	Tanggal & Hari	○ Single select dropdown ○ Sumber data → Master data jadwal dokter (?) ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Varchar (100) ○ Editable
10	Jam Praktik	○ Single select dropdown ○ Editable ○ Sumber data → Master data jadwal dokter (?) ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Varchar (100) ○ Terdapat flagging → ○ Sedang berlangsung ○ Akan datang
11	Kuota	○ Autofill ○ Sistem memotong kuota saat itu juga dan membuat kunjungan. ○ Example: 1 dari 90 ○ Sumber data → Master data jadwal dokter (?) ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Varchar (100) ○ Editable
12	Penunjang	○ Jika layanan == penunjang && klinik dan penunjang maka field input penunjang muncul ○ Single select dropdown ○ Pilihan → ○ Laboratorium ○ Radiologi ○ dll ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Enum ○ Editable
13	Nomor Order	○ Jika layanan == penunjang && klinik dan penunjang maka field input nomor order muncul ○ Single select dropdown ○ Pilihan → ○ Nomor order yang aktif ○ Mandatory ○ Tipe data → Varchar (20) ○ Sumber data → Order pemeriksaan penunjang ○ Editable

B.4. Tambah Pasien Baru dan Pasien Lama → Section Skrining Batuk

1	Apakah pasien batuk?	○ Radio button ○ Editable ○ Mandatory ○ Tipe data → Boolean ○ Default → Tidak ○ Pilihan → ○ Ya ○ Tidak
---	----------------------	---

B.5 Tambah Pasien Baru dan Pasien Lama → Section Tambahkan Penanggung Jawab

1	Nama	○ Text Input ○ Tipe data → Varchar (255) atau TEXT ○ Opsional
2	No Telepon	○ Numerik Input ○ Tipe data → Varchar (20) ○ Opsional ○ Format: Awali nomor telepon dengan angka 0 ○ Example: 081290908890
3	Alamat	○ Text Input ○ Tipe data → Varchar (255) atau TEXT ○ Opsional

B.5.1 Tambah Pasien Baru dan Pasien Lama → Section Penanggung Jawab Keuangan

1	Nama	○ Text Input ○ Tipe data → Varchar (255) atau TEXT ○ Opsional
2	No Telepon	○ Numerik Input ○ Tipe data → Varchar (20) ○ Opsional ○ Format: Awali nomor telepon dengan angka 0 ○ Example: 081290908890

3	Alamat	○ Text Input ○ Tipe data → Varchar (255) atau TEXT ○ Opsional
B.6. Tambah Pasien Baru dan Pasien Lama → Section Buat SEP		
1	Tanggal SEP	○ Default by sistem → Editable ○ Datepicker Input ○ Format Data → DD/MM/YYYY ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data → Date
2	No Kartu	○ Tipe data → Varchar (20) ○ Max Varchar → 20 ○ Min Varchar → 0 ○ Numerik input ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Unique (tidak boleh ada duplikasi value dalam sistem) ○ Tidak boleh desimal
3	Pasien CoB	○ Tipe data → Boolean ○ Tipe field → Checkbox ○ Default value → False ○ Opsional
4	Asal Rujukan	○ Radio Button Input ○ Default null/kosong ○ Pilihan → ○ Faskes Tingkat 1 ○ Faskes Tingkat 2 ○ Opsional
5	No Rujukan	○ Tipe data → Varchar (20) ○ Max Varchar → 20 ○ Min Varchar → 0 ○ Numerik input ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Unique (tidak boleh ada duplikasi value dalam sistem) ○ Tidak boleh desimal

6	PPK Asal Peserta	○ Text Input ○ Tipe data → Varchar (255) atau TEXT ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah
7	Catatan	○ Text Input ○ Tipe data → Varchar (255) atau TEXT ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah
8	No SKDP	
9	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan	○ Single dropdown input ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Tipe data →
10	Nama Sub/Spesialis	
11	Poli Eksklusif	○ Tipe data → Boolean ○ Tipe field → Checkbox ○ Default value → False ○ Opsional
12	No Telepon	○ Numerik Input ○ Tipe data → Varchar (20) ○ Mandatory → Beri tanda (*) merah ○ Format: Awali nomor telepon dengan angka 0 ○ Example: 081290908890
13	Diagnosa	
14	Pasien Katarak	○ Tipe data → Boolean ○ Tipe field → Checkbox ○ Default value → False ○ Opsional
15	Tujuan Kunjungan	○ Single dropdown input ○ Pilihan → ○ Normal ○ Prosedur

		○ Konsul Dokter ○ Opsional ○ Tipe data →
16	Jenis Prosedur	○ Single dropdown input ○ Pilihan → ○ Prosedur Tidak Berkelanjutan ○ Prosedur dan Terapi Berkelanjutan ○ Opsional ○ Field ini aktif jika tujuan kunjungan == Prosedur ○ Tipe data →
17	Jenis Penunjang	○ Single dropdown input ○ Pilihan → ○ Radioterapi ○ Kemoterapi ○ Rehabilitasi Psikososial ○ Transfusi Darah ○ Pelayanan Gigi ○ HEMODIALISA ○ Opsional ○ Field ini aktif jika tujuan kunjungan == Prosedur ○ Tipe data →
18	Alasan Kunjungan	○ Single dropdown input ○ Pilihan → ○ Poli spesialis tidak tersedia pada hari sebelumnya ○ Jam poli telah berakhir pada hari sebelumnya ○ Dokter spesialis yang dimaksud tidak praktek pada hari sebelumnya ○ Atas instruksi RS ○ Tujuan kontrol ○ Opsional ○ Field ini aktif jika tujuan kunjungan == Normal & Konsul Dokter ○ Tipe data →
19	Status Kecelakaan	○ Single dropdown input ○ Pilihan → ○ Bukan Kecelakaan ○ Kecelakaan Lalu Lintas dan Bukan Kecelakaan Kerja ○ Kecelakaan Lalu Lintas dan Kecelakaan Kerja ○ Kecelakaan Kerja

		○ Opsional ○ Tipe data →
20	Hak Kelas Rawat	○ Single dropdown input ○ Pilihan → ○ Kelas 1 ○ Kelas 2 ○ Kelas 3 ○ Opsional ○ Tipe data →
21	Naik Kelas Rawat	○ Single dropdown input ○ Pilihan → ○ VVIP ○ VIP ○ Kelas 1 ○ Kelas 2 ○ Kelas 3 ○ ICCU ○ ICU ○ Opsional ○ Tipe data →
22	Pembiayaan	○ Single dropdown input ○ Pilihan → ○ Pribadi ○ Pemberi Kerja ○ Asuransi Kesehatan Tambahan ○ Opsional ○ Tipe data →
23	Penanggung Jawab	○ Text Input ○ Tipe data → Varchar (255) atau TEXT ○ Opsional
24	No Laporan Polisi	○ Tipe data → Varchar (20) ○ Max Varchar → 20 ○ Min Varchar → 0 ○ Text input ○ Opsional

		Field ini aktif jika status kecelakaan != Bukan Kecelakaan
25	Bukti Laporan Polisi	- Tipe data → - Upload Gambar - Field ini aktif jika status kecelakaan != Bukan Kecelakaan - Opsional
26	Tanggal Kecelakaan	- Datepicker Input - Format Data → DD/MM/YYYY - Opsional - Tipe data → Date - Field ini aktif jika status kecelakaan != Bukan Kecelakaan
27	Penjamin Kecelakaan	- Checkbox - Multiple select - Pilihan → - PT Jasa Raharja - BPJS Kesehatan - PT Taspen - PT ASABRI - Tipe data → - Field ini aktif jika status kecelakaan != Bukan Kecelakaan - Opsional
28	Pasien Suplesi	- Tipe data → Boolean - Tipe field → Checkbox - Default value → False - Opsional - Field ini aktif jika status kecelakaan != Bukan Kecelakaan
29	Keterangan Kecelakaan	- Text Input - Tipe data → Varchar (255) atau TEXT - Mandatory → Beri tanda (*) merah - Field ini aktif jika status kecelakaan != Bukan Kecelakaan
30	Provinsi	- Single dropdown input - Sumber data → Master data provinsi - Opsional - Tipe data → Varchar(255) - Field ini aktif jika status kecelakaan != Bukan Kecelakaan

31	Kabupaten	- Single dropdown input - Sumber data → Master data kabupaten - Opsional - Tipe data → Varchar(255) - Field ini aktif jika status kecelakaan != Bukan Kecelakaan
32	Kecamatan	- Single dropdown input - Sumber data → Master data kecamatan - Opsional - Tipe data → Varchar(255) - Field ini aktif jika status kecelakaan != Bukan Kecelakaan
B.7. Tambah Pasien Baru dan Pasien Lama → Section Register Sidik Jari		
1	Pendaftaran Sidik Jari	Input fingerprint
C. Update Data Pasien Lama		
1	Ubah data pasien lama	Menampilkan semua data yang telah diinput sebelumnya
D. Detail Data Pasien / Data Sosial		
1	Detail data pasien lama	Menampilkan semua data yang telah diinput sebelumnya - B1 → Section Informasi Pribadi - B3 → Hanya menampilkan field Tanggal SEP, Asal Rujukan, No Kartu, No Rujukan, No SKDP, No Telepon, Catatan, Status Kecelakaan, Nama Sub/Spesialis, Diagnosa
E. Riwayat Pembatalan Pendaftaran		
1	No Antrean	Get data no antrean pada data pasien di pendaftaran
2	No Pendaftaran	Get data no pendaftaran pada data pasien di pendaftaran
3	No RM	Get data no rm pada data pasien di pendaftaran

4	Nama	○ Get data nama pada data pasien di pendaftaran
5	No SEP	○ Get data no SEP pada data pasien di pendaftaran
6	NIK	○ Get data NIK pada data pasien di pendaftaran
7	Klinik	○ Get data klinik pada data pasien di pendaftaran
8	Alamat	○ Get data alamat pada data pasien di pendaftaran
9	Cara Pembayaran	○ Get data tipe penjamin pada data pasien di pendaftaran
10	Dibatalkan Oleh	○ Get data canceled_by dari user yang melakukan batal periksa
11	Dibatalkan Pada	○ Get data canceled_date dari tanggal dan waktu user melakukan batal periksa

Change Log

No	Item	Perubahan	Event
1	•	•	•

Informasi Lain

Detail Diskusi

Diskusi Layout Pendaftaran RJ

Dashboard Pendaftaran RJ

1. beberapa hal ini yang jadi poin penting untuk di halaman dashboard pendaftaran, harus langsung visible mas
 - a. No. Antrean — referensi utama untuk komunikasi dengan poli & pasien
 - b. Pasien — gabung Nama + No RM + badge Baru/Lama + icon prioritas
 - c. Klinik & Dokter — gabung nama klinik + dokter (multi-line dalam 1 cell)
 - d. Cara Bayar/ Penjamin — (BPJS / Umum / Asuransi)
 - e. Jenis Pendaftaran — (Reguler / Booking / Mobile JKN / Rujuk Internal)
 - f. Status Kunjungan — (Terjadwal / Hadir / Selesai / Dibatalkan) Aksi - checkin, batal periksa (mungkin ini bisa diakses lebih mudah juga, kalau di v1 kaya ketika expand ada icon itu)
2. terus notesnya tadi kalau bisa kaya datanya dicompact-kan, kalau ada yang bisa dimasukkan ke yang lain, gapapa dimasukkan atau digabung. mungkin gambarannya kaya gini , terus jenis pasien baru/lama kaya didekat nama pasien aja nempel, icon fingerprint untuk yang sep bisa disitu juga, sama misal ada icon prioritas juga
3. Terkait penamaan no pendaftaran/no registrasi, masih dipastikan dulu dengan tim terkait.
4. Sorting tetap di No. Pendaftaran (registrasi), check-in tidak mempengaruhi urutan
5. Tampilkan dua waktu: waktu terdaftar + waktu check-in (terutama untuk pasien booking)

Pendaftaran Pasien Rawat Jalan



↓ Ekspor

+ Pendaftar

🔍 Cari nama atau No RM...

05/06/2026

Semua Unit ▾

Filter Lainnya

Antrean	Pasien	Klinik & Dokter	Penjamin	Jenis Daftar	Status	Aksi
J-031 10:10	Iwan Setiawan Baru RM 073454 📄	Klinik Keluarga Sakinah dr. Izzatul Muna	BPJS	Rujuk Internal	🕒 Terjadwal	🔗 ✕ ⋮
J-030 10:10	Siti Rahmawati RM 073456	Rumah Gizi dr. Siti Rahmawati	Asuransi	Reguler	✓ Hadir	🖨 ✕ ⋮
J-027 10:10	Rudi Hartono Baru RM 073459	Klinik Jantung dr. Rudi Hartono	BPJS	Reguler	✓ Hadir	🖨 ✕ ⋮
J-029 10:10	Iwan Setiawan Baru RM 073457	Klinik Bedah Umum dr. Iwan Setiawan	Umum	Booking	Selesai	🖨 ⋮
J-028 10:10	Dina Anisa RM 073458	Klinik Gizi dr. Dina Anisa	BPJS	📄 MJKN	✕ Batal	⋮
J-026 10:09	Nina Lestari RM 073460	Klinik Jantung dr. Nina Lestari	BPJS	Reguler	✓ Hadir	🖨 ✕ ⋮

Pencarian & Identifikasi Pasien

Konteks: Pada form Tambah Pendaftar, alur pasien baru (langsung isi form) dan pasien lama (cari dulu) masih menyatu dalam satu tampilan, dan ada risiko data pasien langsung masuk ke form begitu kandidat di hasil pencarian ter-klik.

Rekomendasi:

1. **Data pasien sebaiknya hanya masuk ke form lewat modal verifikasi — bukan langsung saat kandidat ter-klik.**
Alurnya: petugas klik kandidat → muncul modal "Detail Pencarian" (nama, tanggal lahir, No. RM, NIK, alamat) → petugas verifikasi → tekan "Pilih Pasien" → baru data ter-isi ke form. Jadi modal ini menjadi satu-satunya pintu masuk data ke form. Tujuannya mencegah salah pilih akibat misklik — risiko rekam medis tertukar terlalu fatal untuk dilewatkan. Pendekatan ini juga memenuhi syarat verifikasi dua identitas (nama + tanggal lahir) di PRD.
 - *Usulan tambahan: modal mendukung keyboard (Enter = Pilih Pasien, Esc = Batal), karena ~60–80% kunjungan adalah pasien lama sehingga modal ini sering muncul.*
2. **Kondisi "pasien tidak ditemukan" sebaiknya punya dua pintu keluar yang jelas:** opsi "Cari lebih detail" (kombinasi NIK / tanggal lahir / alamat — untuk membedakan nama yang mirip) dan opsi "Daftar Pasien Baru".

Aturan terkait Autofill & Verifikasi NIK - No Kartu BPJS

Grooming 15 Juni 2026

Notes Diskusi

- Siapa yang bertanggungjawab -
- Siapa yang mendokumentasikan - gimana mendokumentasikan kalau ada yang bersinggungan dengan tribes lain
 - A berkaitan dengan B. B dioverview singkat dulu, kenapa terhubung dengan A. Mengapa terhubung dengan apa. Detail alur lainnya akan dibahas di sesi lain.